Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2026
tom 11, e05326021
Copyright © 2026 Via Medica
ISSN 2451–0122, e-ISSN 2451–1943
DOI: 10.5603/gipp.114853

W artykule: Drosdzol-Cop A, Huras H, Kwiatkowski S, Stojko R, Zimmer M, Sieroszewski P. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatów zawierających nifuratel i nystatynę (Macmiror/Macmiror Complex®) w leczeniu bakteryjnej waginozy, rzęsistkowicy oraz innych zapaleń pochwy o złożonej etiologii. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna. 2025;10:178–181. doi:10.5603/gipp.110160.

zamiast	**powinno być**
W leczeniu BV, VVC standardowy czas terapii wynosi 7–8 dni (1 globulka dopochwowa/dobę lub równoważna ilość maści — 1 globulka: 50 mg nifuratelu + 20 000 j.m. nystatyny; 1 g maści dopochwowej: 100 mg nifuratelu + 40 000 j.m. nystatyny) [12, 15].	W leczeniu BV, VVC standardowy czas terapii wynosi 7–8 dni (1 globulka dopochwowa/dobę lub równoważna ilość maści — 1 globulka: **500** mg nifuratelu + 20 000 j.m. nystatyny; 1 g maści dopochwowej: 100 mg nifuratelu + 40 000 j.m. nystatyny) [12, 15].
W leczeniu zapalenia sromu i pochwy spowodowanego przez bakterie tlenowe (*Aerobic vaginitis*) u kobiet w wieku okołomenopauzalnym i dziewczynek w okresie ciszy hormonalnej zaleca się standardową terapię — 7–8 dni (1 globulka dopochwowa/dobę lub równoważna ilość maści dopochwowo lub na okolicę sromu u dziewczynek) [11].	W leczeniu zapalenia sromu i pochwy spowodowanego przez bakterie tlenowe (*Aerobic vaginitis*) u kobiet w wieku okołomenopauzalnym i dziewczynek w okresie ciszy hormonalnej zaleca się standardową terapię — 7–8 dni (1 globulka dopochwowa/dobę lub równoważna ilość maści dopochwowo lub na okolicę sromu u dziewczynek*****) [11]. ***Dziewczynkom w wieku szkolnym podawać połowę dawki zalecanej u pacjentek dorosłych, czyli 1,25 g maści**

Wersja artykułu dostępna na: https://journals.viamedica.pl/ginekologia_perinatologia_prakt/article/view/110160 jest prawidłowa.